西昌市医院彝族患者医疗语言服务需求与供给调查*

姜昕玫

（中央民族大学　中国少数民族语言文学学院　北京　100081）

提　要　语言弱势群体就医时经常面临沟通障碍，需重视医疗领域语言服务。本研究聚焦少数民族患者，采用问卷调查法、访谈法和观察法，对四川凉山彝族自治州西昌市3家医院的彝族患者和医护人员进行了调查，发现当地医疗语言服务需求如下：医患双方语言能力不一致较为显著，沟通障碍既涉及语言也涉及文字，医患均有语言服务需求；医疗语言服务资源需求差异较大，对志愿者和双语医护人员的人力资源需求度高，对文字信息资源需求度低，医生对技术资源的需求远高于患者；政策保障方面也存在需求。服务供给的现状是尚未建立志愿语言服务体系、线上科普资源不足、医院语言景观信息传递功能弱、技术资源匮乏和政策保障供给碎片化。可以从以下几个方面进行优化：强化供给主体多元性，建立医疗语言志愿服务体系；充分构建和开发医疗语言服务人力资源，加强医患语言能力一致性；从应用层面增强技术资源支持，开发医患翻译机、远程翻译平台；建立系统完善的医疗语言服务政策法律法规保障体系。

关键词　应急语言服务；医患沟通；语言政策；语言障碍；语言生活

中图分类号　H002　**文献标识码**　A　**文章编号**　2096-1014（2025）04-0034-10

DOI　10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20250404

A Survey on the Demand and Supply of Medical Language Services for Yi Ethnic Minority Patients in Xichang Hospitals

Jiang Xinmei

Abstract　Patients from linguistically disadvantaged groups often face communication barriers when seeking medical care, highlighting the importance of language services in healthcare settings. This study focuses on ethnic minority patients, employing questionnaire surveys, interviews, and observations to investigate the situation in three hospitals in Xichang City, Liangshan Yi Autonomous Prefecture, Sichuan Province. The findings include significant disparities in language proficiency between healthcare providers and Yi patients, communication barriers involving both spoken and written language, and a shared need for language services among healthcare professionals and patients. The demand for medical language service resources varies considerably: there is a high demand for human resources such as bilingual healthcare workers and volunteers, while the need for written resources is lower. Additionally, medical professionals exhibit a greater need for technical resources compared to patients. There is also a demand for policy guarantees in this domain. The study suggests optimization in the following areas: enhancing the diversity of service providers and establishing a volunteer-based medical language service system; building and improving human resource capacity for medical language services to align with patients and healthcare providers' language

*　作者简介：姜昕玫，女，中央民族大学副教授，语言治理研究融智协同创新中心研究员，主要研究方向为社会语言学。电子邮箱：jiang.2017@muc.edu.cn。

国家语委“十四五”科研规划2022年度重点项目（中青班项目）“民族地区应急语言服务需求与实践策略研究”（ZDI145-68）。

中国知网　https://www.cnki.net

abilities; strengthening technological support through tools like translation devices and remote translation platforms; and developing a comprehensive system of policies and legal frameworks to ensure adequate medical language services.

Keywords　emergency language services; doctor-patient communication; language policy; language barriers; language situation

一、引　言

随着全国交通运输条件的提升和居民生活水平的提高，偏远地区、农村地区、民族地区居民跨地区就医、赴城市就医现象增多，2023 年跨省异地就医直接结算达 1.29 亿人次。[①] 异地就医时语言弱势群体[②]常面临沟通障碍，且医学术语庞杂、专业性强加大了翻译难度，亟须公共服务体系建设重视医疗领域语言服务。党的二十大报告指出要“健全基本公共服务体系，提高公共服务水平”[③]。《医学人文关怀提升行动方案（2024—2027年）》提出要“增进医患沟通”[④]。本文医疗语言服务指：为消除医疗领域跨语言或方言沟通障碍，行为主体以语言文字为内容或手段，为医患双方提供帮助的行为和活动。

医疗语言服务场景可分为 3 类：第一，医生跨区域诊疗，大型公共卫生事件发生时医生需要跨区域治疗疫区患者，例如新冠疫情期间，援鄂医疗队与患者沟通不畅，中国语言学人研制多个语言服务产品（李宇明，等 2020）；第二，自然灾害发生时，语言弱势群体集体异地就医，例如青海玉树地震后，百余名藏族灾民在兰州就医有沟通障碍，志愿者提供了翻译服务（孙春颖，杨书俊 2011）；第三，国家通用语言文字水平不高的个体脱离母语环境异地就医，或本地就医但与医生语言不一致导致的沟通障碍，例如 2024 年西藏昌都患儿到杭州就医，志愿者为其一家提供了翻译服务[⑤]。

国内外学者立足医患沟通障碍，从不同视角、针对不同研究对象产出了一大批研究成果。国外医疗语言服务研究方面，涉及服务需求分析（Ternström et al. 2024）；服务途径研究，如不同翻译方式对比（Gany et al. 2007）、翻译错误分析（Bravo et al.2021）、翻译培训（Müller et al. 2023）、人工智能翻译可靠性分析（Dzuali et al. 2024）等；医患沟通障碍解决策略（Betancourt & Tan-McGrory 2014）；医疗语言服务人力资源（Abdi et al. 2024）和技术资源（Kwok et al. 2021）；等等。

国内医疗语言服务研究的深度广度与国际研究存在一定差距。研究涉及的群体方面，关注外籍人士（苏伟 2010；郭聪，杨承淑 2020；郑洪波，黄丽萍 2020）、听障人士（郑璇 2021；左逸菲 2023）成果较多，系统关注少数民族群体的成果较少（景艳云，等 2019），岩温罕（2020）、石琳（2021）等关注了新冠疫情期间少数民族语言服务情况及存在的问题。研究涉及的地域方面，关注发达地区和重点城市医疗语言服务供需的成果多（詹成，严敏宾 2013；李现乐，龚余娟 2015）等，关注偏远地区

① 《全国医疗保障跨省异地就医直接结算公共服务信息发布（第五十九期）》，国家医疗保障局网，2024-01-09，http://www.nhsa.gov.cn/art/2024/1/29/art_114_12032.html。

② 此处语言弱势群体指与社会因素有关的外因导致的社会性语言弱势群体，即身体机能和语言学习能力正常但因异地就医脱离母语环境遇到语言沟通障碍的群体。

③ 《习近平：高举中国特色社会主义伟大旗帜　为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，中国政府网，2022-10-25，https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm。

④ 《关于印发医学人文关怀提升行动方案（2024—2027 年）的通知》，中国政府网，2024-09-29，https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6979036.htm。

⑤ 《“寻找在杭藏语志愿者”，牵动全城求助消息的背后……》，新华网，2024-01-24，http://zj.news.cn/20240124/9f31d1a3981a43f39d20ee9ce7fb04cb/c.html。

中国知网　https://www.cnki.net

和县级城市的成果少。本文选取凉山彝族自治州（简称凉山州）西昌市为调查点，分析当地医患语言服务需求和医疗语言服务供给现状，并提出服务优化方向。

二、调查设计

本研究选择凉山州府所在地西昌市作为调查地的原因，首先是凉山州属“三区三州”地区，“三区三州”普通话普及率仅 61.56%，大幅低于全国平均数据 80.72%（陈丽湘 2021）；其次凉山州是全国彝族最集中的地区，州内彝族常赴西昌市就医，医生大都掌握普通话、西南官话，部分掌握彝语，医患存在一定沟通障碍。

（一）调查点和调查方式

依据凉山州彝族就医习惯，选择西昌市 3 家医院作为调查点：西昌市人民医院、凉山彝族自治州第一人民医院、凉山彝族自治州中西医结合医院。调查方法如下。（1）问卷调查法：调查员[①]一对一当面询问患者或医护人员后根据其回答圈选答案并记录补充信息，采用随机抽样获取有效问卷 158 份；（2）访谈法：采用深度访谈法访谈凉山州中西医结合医院院长 Z、凉山州语言文字工作服务中心民族语文科科长 Y、凉山州应急管理局宣传动员科科员 M；（3）观察法：搜集 3 个医院语言景观资料，拍摄标识 78 张，同时走访不同科室观察医患交流用语。

（二）问卷调查受访者基本信息

问卷调查受访者包括 90 名患者和 68 名医护人员，患者以彝族为主（86 人，95.6%），年龄分布均衡，具体见表 1；医护人员女性占多数（64.7%）、中青年占多数（34 岁以下占 60.3%）；医生 40 人占 58.8%，护士 23 人占 33.8%，其余 5 人为行政人员和技师。

表 1　受访患者基本信息（N = 90）

性别 / 年龄	男	女	25 岁以下	26—44 岁	45 岁以上
人数	56/62.2%	34/37.8%	35/38.9%	32/35.5%	23/25.6%
受教育程度	没上过学	小学	初中	高中	大专及以上
人数	15/16.7%	17/18.9%	23/25.6%	13/14.4%	22/24.4%

三、西昌市医患双方医疗语言服务需求分析

提供优质语言服务的前提是了解服务对象的需求，以服务对象的需要、满意和方便为目标（李宇明 2013）。以下从服务参与主体、服务资源、服务政策分析西昌市医疗领域语言服务需求。

（一）医疗语言服务主体需求的形成及互动障碍类型

医疗语言服务的参与主体包括服务的提供者和接受者。提供者包括具备双语沟通能力的志愿者、医护人员、家属等人员和相关翻译部门或机构。接受者包括医护人员、患者及家属。

1. 医疗语言服务主体：医患语言能力不一致引发服务需求

医患双方存在沟通困难是语言服务的前提。数据表明，西昌市的医院存在医患语言能力不一致现象，医患均有语言服务需求。语言能力不一致表现在：患者熟练掌握彝语的比例明显高于医护人员，医护人员国家通用语言文字能力高于患者，具体见表 2。

① 调查由笔者及中央民族大学 2022 级中国少数民族语言文学古文字强基班同学共同完成，调查时间为 2023 年 7 月。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2　受访者语言文字能力（N = 68/90，可多选）

掌握语言	普通话	当地方言	彝语	藏语	英语
医护人员	67/98.5%	45/66.2%	22/32.4%	2/2.9%	4/5.9%
患者	78/86.7%	60/66.7%	86/95.6%	1/1.1%	0
掌握文字	汉字	英文	彝文	不识字	
医护人员	68/100%	21/30.9%	11/16.2%	0	
患者	61/67.8%	0	26/28.9%	12/13.3%	

2. 主体互动的沟通障碍类型：既涉及语言也涉及文字

医疗语言服务主体的沟通障碍类型决定服务资源的优先供给方向，西昌市医患沟通障碍既表现在语言方面也表现在文字方面。患者表示，遇到的语言障碍为听不懂医护人员讲专业知识（18 人，20%）和无法跟医护人员沟通（9 人，10%），文字障碍为看不懂诊疗单据（14 人，15.6%）、看不懂医院标识（12人，13.3%）、看不懂药品说明（11人，12.2%）和无法填写患者情况表格（5人，5.6%）。[①] 患者 M（男，52 岁）表示："因为看不懂汉字，普通话也不好，到医院后找不到彩超室、住院部，无法跟着医院的指示牌走。"

（二）医疗语言服务资源需求

1. 人力资源：亟须志愿者和双语医护人员提供语言服务

人力资源在医疗语言服务资源中占重要地位，大部分患者倾向于使用由人力资源提供的面对面语言服务（Locatis et al. 2010），在翻译时，译者还可向患者补充解释医学知识，向医生解释不同族群之间的文化差异（Yang et al. 2023）。新冠疫情期间，凉山彝族群众非常期望获得双语医疗服务（石琳2021）。

志愿者是解决医患沟通障碍的重要服务主体，尤其在专业口译资源不足时，志愿者特别是经过培训和有服务经验的志愿者是人力资源的重要组成部分，他们在重大突发公共事件中可以作为有效的信息传递者（Abdi et al. 2024），也可以帮助降低急诊复诊率（Anaya et al. 2024）。数据表明，医生和患者在选择期望解决沟通障碍的途径时，期望获得志愿者帮助的比例最高，分别为 63.2% 和 70%；在应急场景中，有 63.2% 的医护人员选择期望建立志愿服务体系协助突发事件中的医患沟通。

彝汉双语医护人员在面对彝族患者时会形成医患语言能力一致（language concordance）。医患语言能力一致指医患双方可以同时使用各自熟练掌握的语言或方言无障碍沟通，可提升患者满意度，让患者更好地理解诊疗过程和诊治结果，获得更高质量的护理服务（Diamond et al. 2019）。与志愿者或家属翻译相比，医患语言能力一致可降低沟通时间成本，预留更多时间问诊（Quigley et al. 2024）。例如，H 护士（女，40 岁，熟练掌握彝汉双语）表示："我的患者 80% 是彝族，用彝语沟通，没有障碍。"数据表明，患者期望得到双语医护人员提供医疗服务的比例最高（70%）；医护人员期望得到同事协助解决沟通障碍的比例为 55.9%，仅次于志愿服务比例（63.2%）。可见医疗领域语言服务需求中人力资源需求占首位。

2. 信息资源：文字信息资源类语言服务需求度低

医疗语言服务常见信息资源包括医院语言景观、线上线下科普信息、就诊单据和药品信息等。在就医过程中，患者接收的很多信息通过国家通用语言文字和少数民族语言文字传递，但有语言服务需

① 此处为多选题，28 名患者认为与医护人员沟通存在一种或多种语言障碍，62 名患者使用国家通用语言或当地方言可以与医生沟通，认为没有语言障碍。

中国知网 https://www.cnki.net

求的彝族患者总体对文字翻译需求不高。数据表明，医患双方认为医疗活动中各类文字材料需要翻译的比例均不超过 10%（见表 3）。文字信息资源需求度低的原因可能是：有的患者（13.3%）因受教育水平不高，不认识汉字和彝文；彝族患者中掌握彝文的不具有普遍性，仅约三分之一的患者掌握彝文且其中大部分患者同时掌握汉字。比较而言，一些少数民族群体对文字类语言服务资源需求较高，在新冠疫情期间，内蒙古赤峰市、鄂尔多斯市民委制作了蒙汉双文版疫情防控知识手册、标语、指南等材料，满足了群众需求（玲斯玛，胡吉亚 2020）。

表 3　信息资源需求（N = 68/90，可多选）

障碍解决途径	提供民族文字版单据	药品说明增加民族文字	医院设民族文字牌匾标识	增加民族文字版患者自述表格
医护人员	5/7.4%	5/7.4%	0	0
患者	4/4.4%	8/8.9%	4/4.4%	4/4.4%

3. 技术资源：应急场景有“热线”服务需求，医生技术资源需求多于患者

医疗领域语言服务技术资源包括医患翻译机、远程视频翻译系统、带有翻译功能的远程医疗平台和各类翻译软件等。现代化语言服务手段在日常医疗活动中可减少患者寻找和等待翻译的时间（Jacobs et al. 2012），在应急场景可减少人员流动、避免交叉感染（Kwok et al. 2021），且可同时服务大批量不同语种需求的患者（Barwise et al. 2021）。西昌市医患双方对语言服务技术资源的需求有两个特点：一是医生在应急场景中对“热线电话”的需求高于日常场景，医护人员认为在突发公共事件发生期间政府应开通语言服务热线电话保障医患顺利沟通；二是医生对技术资源的需求高于患者，医生在日常场景和应急场景对翻译软件、翻译机的需求比例都在 30% 左右，患者也有一定需求但比例远低于医护人员（见表 4）。

表 4　技术资源需求（N = 68/90，可多选）

障碍解决途径	远程视频翻译	翻译软件或翻译机	政府语言服务热线	医患翻译平台
医护人员（日常）	2/2.9%	24/35.3%	0	9/13.2%
医护人员（应急）	2/2.9%	18/26.5%	9/13.2%	7/10.3%
患者	2/2.2%	13/14.4%	6/6.7%	9/10.0%

（三）医疗语言服务政策保障需求

医疗语言服务相关政策法律法规可以提升医疗语言服务质量、加快服务机制体制建设。西昌市医疗语言服务参与主体政策需求体现在以下两方面。

医院管理者表示，制定和实施语言服务相关政策需要主管部门和其他有关部门的支持和协调配合，医院内部制定和执行的政策影响范围和执行效能有限。访谈对象 Z（男，凉山州中西医结合医院院长）表示，为了提升医患沟通质量，医院加强了参考资料建设和使用培训，出版了《简明医学术语（彝汉双语手册）》；如果涉及人才招聘条件和指标、志愿者招募培训，就需要协调上级主管部门和相关单位一起制定和完善相关政策。目前，凉山州的部分医院出台了医护人员兼职做志愿者、加强医护人员双语技能培训、出版双语医学资料等政策，但在人才招聘、志愿者招募培训、翻译平台和热线服务建设、医院语言景观规范等方面，还缺少主管单位和立法部门在政策引导上的关注和支持。

医护人员表示，加强医患跨语言沟通质量需要在现有政策基础上配套更细致的政策措施。护士 H（女，40 岁）表示：“我是彝族，我跟患者沟通没有障碍，我也很乐意帮助同事跟病人沟通，但有时候

中国知网 https://www.cnki.net

我可能忙不过来，或者到其他科室帮忙时有的术语我也拿不准，只能尽量解释，还是需要加强学习培训。如果医院能够出台招聘专职翻译人员的政策，那是最好的。”从医护人员角度看，协助医患沟通是兼职工作，他们期望医院从政策层面能够给予职业发展、工作环境和福利制度方面的支持。

四、西昌市针对彝族患者的医疗语言服务供给现状

（一）医疗语言服务主体供给

1. 日常医患沟通语言服务供给主体主要为双语医护人员和患者家属

西昌市医患遇到沟通障碍需要语言服务时，供给主体主要为双语医护人员和患者家属。一方面，医患遇到沟通障碍最常见的解决方式是找医院双语工作者。医护人员找同事翻译的比例达 58.9%，说明医院有一定比例的双语员工。我们抽取的医护中能用汉语、彝语与患者沟通的比例为 38.2%（26 人），因此，双语医护人员作为语言服务者可及性较高，25.6% 的患者靠他们解决沟通障碍。另一方面，医患非常依赖有一定双语能力的患者家属，分别有 24.4% 的患者和 45.6% 的医护人员依靠患者家属解决沟通障碍。患者 A（女，50 岁，熟练掌握彝语，基本不会说普通话）表示：“我做手术来复查，医生是汉族不会彝话，医生说的话我有的听得懂、有的听不懂，需要我儿子陪着才能沟通。”

2. 应急场景医患沟通语言服务供给主体为志愿者、双语医护人员和患者家属

在应急场景中，医疗语言服务供给主体主要为志愿者、双语医护人员和家属。首先，应急场景医患通过志愿者翻译的比例最高（72.7%[①]），说明应急医疗语言服务中志愿者可及性优于日常医疗语言服务。其次，与日常一样，医护人员和家属也是主要供给主体，二者比例分别为 54.5% 和 50.0%。第三，应急场景远程语言服务同日常一样使用频率最低（4.5%），这可能有两个原因：一是受访医护人员多参加的是新冠疫情时期的医疗活动，未遇到通信中断需要远程连接翻译人员的情况；二是受访医护人员就近找到非专业翻译的可能性较大，一般不需要远程医疗语言服务。护士 H（女，40 岁）表示：“不需要很复杂的远程翻译设备或软件，找同事、志愿者或家属翻译就可以。”

（二）医疗语言服务资源供给

1. 人力资源供给：尚未建立志愿服务机制

志愿者是提供医疗语言服务的中坚力量，比如云南利用少数民族大学生资源组建民汉双语志愿服务团，在新冠疫情期间发挥了重要的信息传递作用，平日也可提供应急语言救济等志愿服务（岩温罕 2020）。与之相比，西昌市医护和患者找志愿者协助沟通的比例较低（分别为 5.9% 和 11.1%），这可能是因为当地没有建立完善的志愿语言服务体系，也未充分利用双语大学生资源。患者 A（女，50 岁，熟练掌握彝语，基本不会普通话）表示：“之前电脑旁交费时有志愿者帮忙翻译，最近没有了。”

西昌市医疗语言服务人力资源主要为双语医护人员，他们熟练掌握彝汉双语和医学知识，但因忙于本职工作，兼职翻译时间有限。为解决志愿者不足问题，凉山州第一人民医院于 2023 年组建了医护人员兼职语言服务队，他们手臂佩戴“我会说彝语”的服务标识，帮助患者及时获得语言服务。总之，目前西昌市医疗语言服务领域人力资源供给集中在双语医护人员和家属，缺少志愿者服务。

2. 信息资源供给：线上科普资源不足，医院语言景观传递信息的功能较弱

科普资源方面，凉山州有关部门的官方新媒体账号或医院公众号会不定期发布彝语科普资料，但

① 本段落百分比计算方式：选项总人数除以在自然灾害或突发公共事件救援中有不同程度沟通障碍的医护人员人数（22 人）。

中国知网 https://www.cnki.net

总体数量较少、发布频率较低。例如，凉山州卫生健康委员会通过“健康凉山官微”公众号和“凉山疾控”视频号发布彝语科普信息约18条（含转发），涵盖糖尿病、艾滋病、克山病等内容，6条使用汉字彝语，10条使用汉字彝语彝文，2条使用汉语汉字彝语彝文。比较而言，一些地方的少数民族语言文字线上健康卫生科普资源数量更丰富、疾病涵盖范围广，发布信息的平台也更多，例如蒙古语蒙古文线上科普信息经不完全统计至少有40余条，涉及布病、鼠疫等20余种病症，信息来自“内蒙古日报蒙文版”等视频号和“呼伦贝尔疾控”“活力奈曼”等公众号。

医院语言景观方面，西昌市的医院一些公共标识上的彝文仅作为文化符号，信息传递功能较弱。3个医院抽样拍摄的78个标识中有彝文的占33.3%（26个），主要为医院正门牌匾、院内志愿服务导引标识和彝医特色科室牌匾，按翻译程度可分为两类，一类是彝汉对照翻译，例如“凉山彝族自治州中西医结合医院”“少数民族群众咨询服务窗口”“彝药标本室”；一类仅含彝文医院名称，彝文基本等同于文化符号、没有传递信息的功能，例如科室名称、医生简介、就诊导引的牌匾上仅“四川省彝医医院”译为彝文，其余信息为汉文，这类牌匾占大多数，在26个有彝文的牌匾中占69.2%（18个）。一些民族地区医院重视双语或多语标识建设，例如新疆医科大学第一附属医院电梯楼层指示牌、大厅斜面落地牌、科室牌、楼道导引牌等均标有中文、维吾尔文、英文。①

3. 技术资源供给：缺少针对彝族群体的翻译服务热线和翻译软件硬件

西昌市医患在语言服务需求侧均表示需要语言服务技术资源，但目前西昌市语言服务热线和相应的翻译平台、翻译软件硬件供给匮乏。一方面，已开发的软件和资源利用不足，推广和应用范围不普遍、尚未扩展至医疗领域。例如，汉彝双语应急语言资源智能查询平台（马瑞祯，等2021）的应用未扩展至医疗领域，2023年上线的彝文翻译通APP具有彝汉互译功能，但尚未在彝族群体中广泛应用也未用于医疗领域。另一方面，与国内其他一些少数民族语言的技术服务资源相比较，彝语翻译软件形式单一，只有一款APP，其他语种如蒙古语、藏语、维吾尔语服务资源比较丰富，例如蒙古语资源包括蒙汉翻译AI（小程序）、毅金云（https://www.mengguyu.cn/）、蒙古文词典（小程序）、Onon办公助手（小程序）、奥云蒙古文信息处理平台（http://mgwcl.nmgoyun.com）等。

（三）医疗语言服务政策保障的供给

西昌市医疗语言服务的政策保障供给涉及内容和体系构建两方面。

在内容层面，凉山州医疗语言服务的具体政策供给不足，缺少专门关注医疗卫生领域双语服务的法规条款。《凉山彝族自治州彝族语言文字工作条例》（1992）第三条规定：自治州的各级国家机关和事业单位在政治、经济……卫生、体育、新闻等各个领域里加强彝语文的使用。该条例于2009年修订，修订时删除“卫生领域”，改为“自治州各级国家机关、社会团体、企事业单位及其他组织应当加强彝族语言文字的学习和使用”②。比较而言，其他少数民族自治区、自治州、自治县的部分条例法规有医疗卫生领域双语服务条款。例如《广西壮族自治区少数民族语言文字工作条例》第十七条指出“交通运输、卫生计生、工商、人力资源和社会保障、税务、公安、司法行政、邮政、通信、金融等公共服务机构应当根据实际需要，提供国家通用语言文字和少数民族语言文字双语服务”③。《甘肃省甘南藏族自治州藏语言文字工作条例》第十六条规定：“自治州内的邮电、银行……医院等服务机构的

① 《新疆医科大学第一附属医院》，友昆标识网，http://www.youking.com/articles/xjykdx.html。

② 《凉山彝族自治州彝族语言文字工作条例》（1992），见《民族语文政策法规汇编》（民族出版社，2006）；《凉山彝族自治州彝族语言文字工作条例》（2009修订），北大法宝，https://www.pkulaw.com/lar/a2520604c66efbc7d414826f7cbd5a8ebdfb.html。

③ 国家法律法规数据库，https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?MmM5MGU1YmE2MjAwNzE1YTAxNjRlOTMwMzAzOTA4MTg。

中国知网 https://www.cnki.net

工作人员要用藏语接待藏族顾客及病员，或提供翻译服务。”[①]《甘肃省阿克塞哈萨克族自治县哈萨克语言文字工作条例》第十四条规定：“自治县境内的商业、邮电……卫生等服务行业的工作人员应当用哈萨克语接待哈萨克族顾客及病员，或提供翻译服务。”[②]

在体系构建层面，西昌市医疗语言服务相关政策法律法规的制定缺乏上位法的参考，同时也缺少与医疗语言服务相关政策的横向呼应和医院层面的微观政策建设，整体缺乏系统性、呈现碎片化特征。首先，上位法如《中华人民共和国民族区域自治法（2001）》关注了教育领域、司法领域语言服务权益，未涉及医疗领域，凉山州政策法规也忽略了医疗领域语言服务政策法规的建设。其次，医疗语言服务相关政策法规分散于民族地区医学专业人才培养[③]、少数民族语医学资料资源建设[④]等不同领域，凉山州未呼应上述政策规定形成语言服务政策体系。第三，在微观政策层面，医院未就医患跨语言沟通问题出台配套的政策措施。比较而言，民族地区有医院重视了语言服务问题并出台相应政策，提升了医患沟通的效率和质量。例如，锡林郭勒盟医院修订护士招聘方案、出台《优质护理服务方案》后，蒙古族患者在健康咨询、预检分诊、导诊、住院中都获得了语言服务，减少了医患沟通障碍（景艳云，等 2019）。总之，凉山州现有政策法规尚未针对医疗场景中的跨语言沟通障碍问题构建完备的政策体系，医疗语言服务在政策供给层面仍存在较大完善空间。

五、西昌市医疗语言服务优化方向

（一）强化供给主体多元性，建立医疗语言志愿服务体系

西昌市医患双方在日常医疗和应急场景都对语言志愿服务有强烈需求，亟须建立专业性强的医疗多语志愿服务体系。

一方面，应建立多方协同共建的志愿者服务体系，地方院校、政府部门、行业协会、医疗机构等多方协同共建。地方院校可提供智力支持和人力资源，例如，西昌学院彝语言文化学院招收社会工作、中国少数民族语言文学等专业，设有彝汉英同声传译实验室。政府部门可提供资金支持、政策扶持，例如出台语言志愿服务相关政策。行业协会参与多方协调，也可提供智力支持、专家咨询。医疗机构依据需求提出方案促成医疗语言志愿服务体系的建设。

另一方面，依据“平战”结合策略，建立具有医学知识背景的应急语言服务志愿者人才库。Yang et al.（2023）指出医患双方如果无法找到专业医疗翻译就常依靠患者家属，但家属并未受过专业训练，可能导致低质量沟通、诊断错误、家庭焦虑等问题。因此，建立既有医学专业知识、又具备多语翻译能力的志愿服务队伍至关重要，他们平时可为医疗机构提供服务，在应急场合可为灾中救援、灾后心理抚慰等搭建无障碍沟通桥梁。

（二）充分构建和开发医疗语言服务人力资源，加强医患语言能力一致性

双语医护人员的培养、招聘、培训和资源整合是提升民族地区医患沟通质量的重要途径。第一，

① 北大法宝，https://www.pkulaw.com/lar/f5e75cb2f7e89c8a6e53fe03bbe309b6bdfb.html。

② 《甘肃省阿克塞哈萨克族自治县哈萨克语言文字工作条例》，见《民族语文政策法规汇编》（国家民族出版社，2006）。

③ 《国务院关于进一步贯彻实施中华人民共和国民族区域自治法若干问题的通知》（1991）：“加快民族自治地方医疗卫生技术人才的培养……。”《国务院关于加快发展民族教育的决定》（2015）：“调整民族院校和民族地区高校学科专业结构，重点提高工、农、医、管理等学科比例……。”

④ 《卫生部、国家民委、教育部关于加强少数民族地区医学教育工作的意见》（1980）：“重视使用少数民族语言和翻译出版医学书籍。”

中国知网 https://www.cnki.net

培养双语医护人员，储备医疗语言服务人才。医疗语言服务人才既需要具备双语互译能力，又需要掌握医学专业知识，因此，应建立专门的培养机制和培养体系，例如在民族院校以某一学科为依托，增加医学、翻译、应急管理等交叉培养课程，储备一定数量的专业双语服务人才。第二，民族地区医疗机构应依据不同岗位需求招募双语医护人员。不同科室的双语人才需求有一定差别，急诊、儿科、妇产科、ICU等科室相较于其他科室更需配备双语医护人员，医疗机构应按需引才。第三，同一地区不同医院的语言服务人力资源应加以整合，建立协调共享机制。主管单位应牵头组建医疗语言服务人力资源库，整合域内双语医护人才，以线上线下相结合方式为全域患者服务。

（三）从应用层面增强技术资源支持，开发医患翻译机、远程翻译平台

无论日常需求还是应急资源储备，建立现代化医疗语言服务体系是保障医患沟通的重要优化方向。一方面，相关语言服务企业和远程医疗平台建设应关注医疗领域语言服务，按需开发适用于医疗场景的软件和硬件。在开发医疗语言服务平台时应注意虚实结合，既注重远程面对面真人口译功能，又注重利用人机互译、大语言模型资源建设虚拟翻译平台。另一方面，医疗机构应建立语言服务前沿科技的应用意识，注重培训医护人员使用已开发的翻译机、翻译软件。一些机构和企业的民汉互译软件或硬件虽不是专门面向医疗领域但可用于日常交流，医患可利用现有工具最大限度解决沟通障碍。

（四）建立系统完善的医疗语言服务政策法律法规保障体系

针对政策需求，应建立系统完善的医疗语言服务政策法律法规保障体系。一方面，为保证相关规定的系统性，可出台专门针对医疗语言服务的政策文件，明确其在医疗体系中的地位和作用。例如，可制定“医疗语言服务促进条例”，将医患沟通和多语环境下的语言服务纳入统一框架，确保政策的全面性和针对性。另一方面，可完善现有法律法规，增加医疗语言文字使用相关内容，加强医疗领域与其他相关领域（教育、司法、行政等）的政策协调，确保不同领域语言服务政策相统一。

六、结　语

医疗语言服务研究是提升我国公共服务体系和治理体系现代化的重要组成部分。目前民族地区语言生活研究集中在日常生活、传媒、教育、行政和司法领域，专题探讨医疗领域语言服务现状及问题的成果较少，现有成果主要关注新冠疫情期间的语言服务。本研究以凉山州西昌市医疗领域语言服务为研究对象，并尽量比照其他民族地区医疗语言服务揭示西昌市语言服务的特点。第一，人力资源体系建设不完备。未充分挖掘和利用当地双语人才做志愿服务，相关部门和医院也未创建利于医疗语言服务双语人才招募和培养的机制。第二，信息资源和技术资源建设未引起足够重视。凉山州作为全国彝族最集中地区，其语言服务资源对其他彝族地区有辐射引领和示范作用。但目前线上双语科普资源和翻译软件硬件资源还有待进一步建设。第三，医疗领域语言服务政策指导性和引领性不足。其他民族地区语言文字相关政策法规和医院出台的政策能够注意到医疗卫生领域的跨语言沟通障碍问题，西昌市也应依据当地语言生活实际状况关注医疗领域政策法律法规体系的建构。

总之，加强偏远地区和针对少数民族群体的医疗语言服务，可增强语言弱势群体的幸福感、安全感，使中华各民族平等地享有公共卫生服务和医疗服务，推动实现全国基本医疗卫生服务均等化，对铸牢中华民族共同体意识有重要支撑意义。本文依据凉山州彝族群体的语言文字能力特点，提出医疗语言服务优化路径以口译为主、未涉及文字翻译。至于其他地区是否应重视文字翻译服务，则应依据当地群众的语言能力和医疗领域语言服务需求再做探讨。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

陈丽湘　2021《论新时代民族地区国家通用语言文字的推广普及》,《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》第 6 期。

郭　聪，杨承淑　2020《国际医疗语言服务的需求分析与人才培养》,《外国语言与文化》第 2 期。

景艳云，辛晶晶，寇蕊琴，等　2019《基于少数民族地区蒙古族人群语言不通导致就医不便的护理管理探索与实践》,《中国护理管理》第 S1 期。

李现乐，龚余娟　2015《医疗行业语言服务调查研究》,《中国语言战略》第 2 期。

李宇明　2013《领域语言规划试论》,《华中师范大学学报（人文社会科学版）》第 3 期。

李宇明，赵世举，赫　琳　2020《“战疫语言服务团”的实践与思考》,《语言战略研究》第 3 期。

玲斯玛，胡吉亚　2020《内蒙古自治区抗疫应急语言服务实践》,《语言规划学研究》第 2 期。

马瑞祾，王成平，沙马拉毅　2021《汉彝双语应急语言资源智能查询平台的构建与技术实现》,《西南民族大学学报（自然科学版）》第 6 期。

石　琳　2021《突发公共事件中民族地区的语言应急与公共服务研究——以凉山彝族自治州为例》,《西南民族大学学报（人文社会科学版）》第 1 期。

苏　伟　2010《从“传声筒”到“ 医患关系的协调者”——一项针对医疗译员角色的实证研究》,《外语研究》第 5 期。

孙春颖，杨书俊　2011《青海玉树救灾中的语言障碍与语言援助》，载教育部语言文字信息管理司组编《中国语言生活状况报告（2011）》，北京：商务印书馆。

岩温罕　2020《民族院校在国家应急语言规划中的地位与作用》,《语言规划学研究》第 2 期。

詹　成，严敏宾　2013《国内医疗口译的现状、问题及发展——一项针对广州地区医疗口译活动的实证研究》,《广东外语外贸大学学报》第 3 期。

郑洪波，黄丽萍　2020《导医语言使用状况调查》，载张日培，赵蓉晖《上海语言生活状况报告（2020）》，北京：商务印书馆。

郑　璇　2021《听障人群应急语言服务需求调研：基于访谈文本的质性分析》,《语言政策与规划研究》第 2 期。

左逸菲　2023《医疗领域中的手语服务研究——以 X 医院助聋门诊为例》，上海外国语大学硕士学位论文。

Abdi, N., M. Flores, K. K. Hara-Hubbard, et al. 2024. Bridging culture and language: Encouraging bilingual/multicultural individuals to act as information navigators for their loved-ones and communities during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Health Communication* 29(1), 34–48.

Anaya, M., W. Law, H. L. Montoya, et al. 2025. Discharge interventions for limited English proficiency patients: A scoping review. *Journal of Racial and Ethnic Health Disparities* 12, 1737–1744.

……

（因版面不足，以下参考文献从略，可在中国知网上阅读、下载完整版）

责任编辑：逯琳琳

本期“医院语言生活”专题由王春辉组稿，“汉字与思维”专题由章启群组稿；中文摘要由朱剑审稿，英文摘要由李嵬、周明朗、赵守辉、阎喜、尚国文译审，方小兵终校英文内容。特此感谢。

中国知网　https://www.cnki.net